Síndrome meníngeo e hipertensión endocraneana

SEMIOLOGIA · Clase 40 · signos de estiramiento meníngeo, papiledema, punción lumbar y prueba del edrofonio

1 · MENINGES INFLAMADAS: EL PACIENTE SE DEFIENDE

Irritación meníngea
infecciosa, hemorrágica (sangre subaracnoidea), neoplásica, tóxica, traumática o térmica; también tumor occipital o hernia discal

irrita las meninges y provoca la

Defensa contra el estiramiento
traccionar meninges inflamadas duele: rigidez y flexión refleja

el paciente la refiere como

el examinador la halla como

puede sumar

puede sumar

Síntomas cardinales F1
cefalea intensa, rigidez dolorosa de nuca y dolor al estiramiento

Signos cardinales F1
rigidez de nuca, Brudzinski, Kernig y Lasègue

Síntomas accesorios
confusión, somnolencia, náuseas, vómitos y escalofríos

Signos accesorios F1
fiebre, papiledema, crisis y déficit focal

define la gravedad del

se buscan tras la

junto a los signos orienta el

si Kernig y Brudzinski no se ven

2 · CÓMO SE EXPLORAN LOS SIGNOS MENÍNGEOS

apoya los

Preparación
decúbito dorsal, cama a 0°, explicar el procedimiento y movimientos suaves

estirando desde la nuca

estirando desde la rodilla

estirando desde la pierna

Brudzinski
mano bajo el occipital: flexionar la cabeza hacia el tórax

Kernig
cadera y rodilla a 90°; luego extender la rodilla

Lasègue F2
elevar la pierna extendida, sin doblar la rodilla, sosteniéndola por el tendón de Aquiles

si la meninge se defiende

si no hay dolor ni defensa, es

si la meninge se defiende

si llega a 90° sin dolor, es

en la misma maniobra se busca el midriasis de una o ambas pupilas durante el Brudzinski

si no hay dolor ni defensa, es

Brudzinski positivo
dolor y flexión refleja de caderas y rodillas

Flatau (accesorio)
midriasis de una o ambas pupilas durante el Brudzinski

Kernig positivo
dolor, resistencia y flexión de la cabeza para aliviarlo

Respuesta normal F2
el talón llega a 90° sin dolor; la nuca y la rodilla ceden sin dolor ni defensa

Lasègue positivo F2
dolor y resistencia antes de 90°; obliga a flexionar pierna o tronco

como signo accesorio apoya los

apoya los

pero no es exclusivo:

apoya los

descarta el síndrome en el

si hay papiledema, cuidado con la

3 · CÓMO SE INTERPRETAN

Signos positivos
apoyan la irritación meníngea junto a la clínica y el LCR

con clínica y LCR permite el

Meningismo
irritación meníngea con Kernig y Brudzinski poco evidentes; también sin meningitis

matiza la interpretación del

Lasègue no es exclusivo F2
es también el signo clásico del síndrome radicular (ciática)

también matiza el

Síndrome meníngeo evaluado
la causa y la gravedad dirigen los estudios y la conducta

4 · HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA: PRESIÓN EN UNA CAJA RÍGIDA

Algo ocupa espacio (literatura) F3
tumor, absceso, hemorragia o edema dentro del cráneo

ocupa espacio en una

Caja craneal rígida F3
no hay espacio libre: la presión sube de forma sostenida

produce la

días o semanas después produce

si no se corrige, afecta el

Cefalea intensa F3
presente en el 90-100 % de los casos

también produce el

Papiledema F3 · F4
borde de la papila borroso en el fondo de ojo; aparece días o semanas después

Vómito explosivo F3
en chorro, a veces sin náusea previa; la náusea no descarta HTE

VI par: falso localizador
puede fallar por la presión alta, lejos de la lesión (11j)

primer dato de la tríada:

según evoluciona, pasa por las

obliga a seriar la

segundo dato de la tríada:

Fases del papiledema (literatura) F4
1 incipiente (borde borroso), 2 establecido (papila elevada, hemorragias), 3 crónico, 4 atrófico (pálida, pérdida visual)

Vigilancia oftalmoscópica
fondo de ojo seriado para seguir la evolución

advierte la gravedad de la

su estadio orienta la evolución de la

confirma y sigue la

HTE reconocida y vigilada
la tríada orienta la evaluación y evita una punción insegura

junto al fondo de ojo permite una

5 · ANTES DE PUNZAR: EL RIESGO DE HERNIACIÓN

contraindica por herniación la

Punción lumbar: precaución F5
ante papiledema o una lesión que ocupa espacio, imagen antes de punzar

su razón es el

además se evita si hay

Gradiente de presión F5
si se saca LCR por abajo con la presión alta arriba, el encéfalo es empujado hacia el agujero occipital

Otras contraindicaciones (literatura)
infección de la piel en el sitio, coagulopatía o plaquetas bajas, paciente inestable

y se decide una

empuja el encéfalo y causa la

Herniación F5
compresión del tallo: deterioro de la conciencia, VI par y coma (literatura)

se evita pidiendo imagen para una

Punción segura
fondo de ojo e imagen primero; así se evita la herniación

6 · MIASTENIA: LA PLACA MOTORA Y EL EDROFONIO

Unión neuromuscular F6
la acetilcolina no alcanza bien a sus receptores en la placa motora

produce la debilidad del

Síndrome miasténico F6
debilidad fatigable, diplopía y ptosis

para confirmarlo se usa el

Edrofonio IV (Tensilon, literatura) F6
frena la acetilcolinesterasa; la fuerza mejora en unos 30 segundos y dura unos 5 minutos; atropina a mano

si la fuerza vuelve en segundos, es una

Prueba positiva F6
el párpado se abre y la debilidad mejora: miastenia gravis

cierra el diagnóstico de

Miastenia gravis confirmada
la falla de la placa motora explica la debilidad fatigable

causa · mecanismo · síntoma · síndrome · signo · técnica · diagnóstico · desenlace · ejemplo · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 11e · Sotomayor — teoría del docente (= literatura)